Клинические рекомендации

Кисты челюстно-лицевой области и шеи

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**K04.8** — Корневая киста **K09** — Кисты области рта, не классифицированные в других рубриках **K11.6** — Мукоцеле слюнной железы **L72.0** — Эпидермальная киста **Q18.0** — Пазуха, фистула и киста жаберной щели **Q18.1** — Преаурикулярная пазуха и киста **Q18.2** — Другие пороки развития жаберной щели **Q18.8** — Другие уточненные пороки развития лица и шеи
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 28.07.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Ассоциация общественных объединений "Стоматологическая Ассоциация России"; ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/931_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Классификация кист челюстей 4

2.3 Классификация кист мягких тканей 4

2.4 Происхождение кист шеи и околоушной области 4

2.5 Клиническая картина 5

3. Диагностика 5

3.1 Жалобы и анамнез 6

3.2 Физикальное обследование 6

3.3 Зондирование и перкуссия зубов 6

3.4 Риноскопия 7

3.5 Лучевые исследования 7

3.6 Осмотр оториноларинголога 7

3.7 Патологоанатомическое исследование 7

3.8 Дифференциальная диагностика 7

4. Лечение 8

4.1 Подготовка зубов 8

4.2 Кисты челюстей 8
4.3 Кисты мягких тканей 10
4.4 Малоинвазивные операции 10
4.5 Профилактика раневой инфекции 10
4.6 Лекарственная терапия 11
4.7 Диета 11
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 12
5.1 Показания к госпитализации 12
5.2 Реабилитация 12
5.3 Профилактика и диспансерное наблюдение 12
6. Источник и актуальность 13
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 13

1. Основные положения

- Киста представляет собой полость с оболочкой из соединительнотканного слоя и эпителиальной выстилки, заполненную жидким или полужидким содержимым. Киста растёт за счёт давления содержимого: кость рассасывается, челюсть деформируется.
- Консультация оториноларинголога показана при кисте верхней челюсти, растущей в полость носа или верхнечелюстную пазуху, и при кисте шеи со свищом в глотку или к корню языка. При кисте мягких тканей шеи осмотр оториноларинголога необходим для исключения ларингоцеле.
- Диагноз устанавливается при выявлении кистозной полости в кости или мягких тканях по данным осмотра и лучевых исследований. Окончательный диагноз устанавливается по данным гистологического исследования.
- Лечение хирургическое: оболочку кисты удаляют в пределах здоровых тканей.
- Небольшую кисту (**менее 3 зубов**) лечат амбулаторно. Показания к госпитализации:
  1. киста **более 3 зубов**;
  2. небольшая киста при тяжёлой сопутствующей патологии;
  3. нагноение кисты: экстренная госпитализация.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Киста является опухолевидным образованием: это полость, оболочка которой состоит из наружного соединительнотканного слоя и внутреннего, выстланного преимущественно многослойным плоским эпителием. Содержимым кисты являются серозная жидкость, гной, коллоиды и кристаллы холестерина.

Продукты эпителиальной выстилки и воспаление повышают давление в полости кисты; кислая среда от гипоксии активирует остеокласты, лизис кости преобладает над её образованием, поэтому киста растёт и челюсть деформируется.

2.2 Классификация кист челюстей

Клинико-морфологическая классификация (1975)

1. **Эпителиальные одонтогенные**: первичная (примордиальная кератокиста), киста прорезывания, парадентальная (периодонтальная), десневая, зубосодержащая, фолликулярная, корневая (радикулярная)
2. **Эпителиальные неодонтогенные**: киста резцового канала (носонёбного протока), глобуломаксиллярная (фиссуральная), носогубная (носоальвеолярная, преддверия полости рта), холестеатома
3. **Неэпителиальные**: костные кисты: аневризматическая, травматическая, геморрагическая

Клиническая классификация А. К. Иорданишвили (2000)

1. околозубные: околокорневые, резидуальные, околокоронковые (фолликулярные, кисты прорезывания), ретромолярные (парадентальные);
2. первичная киста (кератокиста);
3. киста носонёбного канала;
4. холестеатомы челюстей;
5. травматические;
6. аневризмальная костная киста;
7. шаровидно-верхнечелюстная киста;
8. носогубная (носоальвеолярная, внекостная).

2.3 Классификация кист мягких тканей

Врождённые

1. аномалии эмбриогенеза: срединные и боковые кисты шеи, кисты околоушной области и корня языка, кисты подъязычной слюнной железы;
2. пороки развития эктодермы: дермоидные и эпидермоидные кисты.

Приобретённые

1. ретенционные кисты сальных желёз (атеромы);
2. травматические;
3. кисты слюнных желёз.

Кисты жаберной щели по Bailey (1929) в модификации Proctor (1955)

Тип	Расположение боковой кисты шеи
I	поверхностно, вдоль передней поверхности грудино-ключично-сосцевидной мышцы, под подкожной мышцей шеи; не соприкасается с влагалищем сосудисто-нервного пучка
II	самый частый: кпереди от грудино-ключично-сосцевидной мышцы и кзади от поднижнечелюстной железы, прилежит латерально к влагалищу сосудисто-нервного пучка
III	между внутренней и наружной сонными артериями, латеральнее боковой стенки глотки
IV	глубже влагалища сосудисто-нервного пучка, в окологлоточном пространстве; открывается в глотку, может распространяться к основанию черепа

2.4 Происхождение кист шеи и околоушной области

Кисты шеи и околоушной области

Киста	Происхождение
Срединная киста шеи	незаращение щитоязычного протока; связана с подъязычной костью и слепым отверстием корня языка, в стенке бывает ткань щитовидной железы
Боковая киста шеи	второй глоточный карман между наружной и внутренней сонными артериями, внутреннее устье расположено в области нёбной миндалины; лежит на сосудисто-нервном пучке, чаще на уровне бифуркации общей сонной артерии
Киста околоушной области	порок развития первой жаберной щели; латеральнее ствола лицевого нерва, связана с наружным слуховым проходом на границе хрящевого и костного отделов
Киста корня языка	аномалия щитоязычного протока; большая киста перед надгортанником мешает есть и дышать, нагноившаяся похожа на абсцесс корня языка
Лимфоэпителиальная киста	из остатков эпителия в лимфоидной ткани; из второй жаберной дуги развивается шейная лимфоэпителиальная киста (киста жаберной щели)

2.5 Клиническая картина

Киста челюсти

1. вне обострения симптомы могут отсутствовать, иногда определяется свищ на коже или слизистой оболочке;
2. большая киста деформирует челюсть: асимметрия лица, выбухание в полости рта;
3. при пальпации определяется «пергаментный хруст» или флюктуация;
4. большая киста смещает прорезывающиеся зубы, может привести к перелому нижней челюсти.

При нагноении кисты отмечаются асимметрия лица за счёт отёка и гиперемия кожи; перкуссия «причинного» зуба, как правило, болезненна. При нагноении фолликулярной кисты у ретенированного восьмого зуба нижней челюсти бывает затруднено открывание рта.

Срединная киста располагается по средней линии шеи между слепым отверстием языка и перешейком щитовидной железы. Она растёт медленно, безболезненная, гладкая, упругоэластическая; **при глотании смещается только вверх** вслед за подъязычной костью. Кожа над ней не изменена.

Боковая киста располагается впереди кивательной мышцы на уровне угла нижней челюсти и выявляется чаще в юношеском возрасте; киста округлая, эластическая, смещаемая.

1. **Дермоидная киста**: под языком и в языке, под мышцами дна полости рта, у корня носа, у углов орбиты, в надбровной области; мягкая, с кожей не спаяна
2. **Киста больших слюнных желёз**: безболезненная мягкоэластическая припухлость в околоушно-жевательной или поднижнечелюстной области; из протока выделяется неизменённая слюна
3. **Ранула**: округлое синюшно-прозрачное безболезненное образование подъязычной области; может опорожняться в рот и наполняться снова
4. **Киста малой слюнной железы**: округлое полупрозрачное, иногда голубоватое образование над слизистой оболочкой, подвижное, безболезненное

При нагноении кисты мягких тканей могут быть затруднены глотание, дыхание, движения языка, болезненны повороты головы; возможен свищ с отделяемым.

---

3. Диагностика

Диагноз кисты устанавливается при выявлении кистозной полости в кости или мягких тканях при осмотре и инструментальном обследовании и после исключения сходной патологии.

3.1 Жалобы и анамнез

Жалобы при кисте челюсти

1. вздутие альвеолярного отростка, асимметрию лица;
2. боль, отёк, припухлость тканей;
3. затруднение носового дыхания;
4. снижение чувствительности кожи нижней губы.

В начале киста бессимптомна.

В анамнезе выясняют

1. травму зуба;
2. степень разрушения зубов кариесом;
3. качество эндодонтического лечения;
4. ретенированные зубы.

Киста от центральных резцов верхней челюсти, растущая в нижний носовой ход, вызывает постоянную заложенность носа, а сдавление носослёзного канала приводит к одностороннему слезотечению.

При нагноении кисты челюсти к тем же жалобам присоединяются повышение температуры тела и озноб. При нагноении кисты, врастающей в верхнечелюстную пазуху, возникают боль в верхней челюсти и одностороннее отделяемое из носа.

При срединной кисте шеи пациентов беспокоят боль при глотании, болезненность в области языка, ощущение инородного тела при глотании, припухлость в передней области шеи.

При боковой кисте шеи пациенты предъявляют жалобы на асимметрию шеи, припухлость (иногда болезненная) в верхней трети боковой области шеи, односторонняя боль при глотании.

При дермоидной кисте мягких тканей пациенты предъявляют жалобы на асимметрию лица и шеи, наличие образования, эстетический дефект, нарушение подвижности языка, глотания и речи.

Жалобы при нагноившейся кисте мягких тканей лица и шеи

1. боль;
2. асимметрию лица или шеи;
3. отёк, припухлость;
4. затруднение дыхания;
5. повышение температуры тела, озноб.

При воспалении срединной, боковой и дермоидной кисты возможна дисфагия с расстройством речи.

3.2 Физикальное обследование

Помимо общего осмотра, выполняются наружный осмотр лица и шеи, осмотр полости рта, поверхностная и глубокая пальпация регионарных лимфатических узлов.

При кисте челюсти определяется сглаженность или выбухание переходной складки преддверия рта или нёба, затем «пергаментный хруст» (симптом Рунге — Дюпюитрена), а при появлении «окна» в кости флюктуация.

Дермоидная киста дна полости рта: эластичная или тестоватая, гладкая, с чёткими границами; киста, прикреплённая к подъязычной кости, образует полушаровидное выпячивание в подподбородочной области. Дермоидные кисты околоушной области лежат глубоко, под стволом лицевого нерва или его ветвями.

3.3 Зондирование и перкуссия зубов

При кисте челюсти выполняются зондирование, перкуссия и оценка подвижности зубов.

3.4 Риноскопия

При кисте носонёбного канала или кисте верхней челюсти, растущей в полость носа, и затруднении носового дыхания показана риноскопия для определения объёма операции и исключения патологии полости носа.

Киста, растущая к нижней стенке грушевидного отверстия, при риноскопии определяется как выпячивание на дне полости носа («валик Гербера»).

3.5 Лучевые исследования

Рентгенография при кисте челюсти

1. прицельная внутриротовая контактная;
2. ортопантомография;
3. панорамная рентгенография нижней челюсти;
4. рентгенография придаточных пазух носа;
5. рентгенография нижней челюсти в прямой и боковой проекциях.

Прицельного внутриротового снимка достаточно при околокорневой кисте **не более 7–10 мм**. При кисте **более 11 мм**, у премоляров и моляров нижней челюсти и при наложении анатомических образований выполняются ортопантомография, панорамный снимок, рентгенография пазух.

Если прицельного снимка недостаточно, выполняются панорамная рентгенография нижней челюсти, конусно-лучевая томография или КТ челюстно-лицевой области для оценки размеров и топографии кисты, состояния слизистой оболочки и стенок верхнечелюстной пазухи и полости носа.

При большой кисте челюсти показана спиральная КТ околоносовых пазух или КТ челюстно-лицевой области.

При кисте мягких тканей лица и шеи выполняются УЗИ мягких тканей и цитологическое исследование материала тонкоигольной аспирационной биопсии для оценки содержимого, размеров и топографии.

Если УЗИ недостаточно информативно, применяют МРТ мягких тканей или КТ челюстно-лицевой области.

3.6 Осмотр оториноларинголога

При кисте мягких тканей лица и шеи необходим осмотр оториноларинголога для исключения ларингоцеле.

3.7 Патологоанатомическое исследование

Патологоанатомическое исследование операционного материала выполняется всем пациентам для исключения злокачественного образования. Окончательный диагноз устанавливается по данным планового гистологического исследования.

3.8 Дифференциальная диагностика

Кисты челюстей дифференцируют с амелобластомой, гемангиомой, миеломой, эозинофильной гранулёмой, центральной гигантоклеточной гранулёмой, гигантоклеточной опухолью, фиброзной дисплазией, мягкой одонтомой, хондромой, остеомой, кистой Стафне, саркомой, метастазами карциномы. Для дифференциальной диагностики применяют КТ, ангиографию, сцинтиграфию, цитологическое исследование пунктата, биопсию.

Кисты околоушной области дифференцируют с кистами и опухолями околоушной слюнной железы и боковыми кистами шеи с помощью МРТ и цитологического исследования пунктата.

Дифференциальная диагностика дермоидных и эпидермоидных кист

1. туберкулёз лимфатических узлов (при первичной форме лёгкие могут быть не поражены);
2. лимфо- и ретикулосаркома: быстрый рост, множественное поражение узлов;
3. опухоли кроветворной системы;
4. аденолимфома слюнных желёз: в пунктате клетки опухоли;
5. боковые и срединные кисты шеи: пунктат дермоидной кисты атеромоподобный, с холестерином;
6. абсцедирующий лимфаденит;
7. атерома: дермоидная киста с кожей не спаяна.

Дифференциальная диагностика боковых и срединных кист

1. хронический лимфаденит шеи;
2. дермоидные кисты;
3. опухоли слюнных желёз (сиалография, МРТ, КТ);
4. каротидная хемодектома (МР- или КТ-ангиография);
5. метастазы, бранхиогенный рак, лимфо- и ретикулосаркома, гемангиома, лимфангиома;
6. для боковых свищей: свищи после нагноения лимфатических узлов.

Атерому отличают от эпидермоидной кисты, липомы, фибромы, лимфаденита, фурункула, ретенционной кисты по точечной втянутости кожи над протоком железы и спаянности кожи с оболочкой кисты.

---

4. Лечение

Основным методом лечения является хирургический: оболочку кисты удаляют в пределах здоровых тканей.

4.1 Подготовка зубов

Зубам, вызвавшим развитие корневой кисты, показаны пломбирование корневых каналов и резекция верхушек корней.

Канал пломбируют до операции, до уровня резекции верхушки, **не менее чем на 2/3 длины**. Если корень визуализируется в кисте во время операции, выполняется резекция верхушки корня уже запломбированного зуба.

Зубам, прилежащим к кисте и не реагирующим на ток при электроодонтометрии, показано пломбирование корневых каналов.

Электроодонтометрия, мкА

1. **2–8**: интактный зуб;
2. **9–14**: кариес;
3. **15–24**: глубокий кариес;
4. **25–44**: пульпит;
5. **45–80 или нет реакции**: периодонтит.

4.2 Кисты челюстей

Перед операцией

1. подписанное согласие пациента;
2. отсутствие хронических заболеваний в стадии декомпенсации и тяжёлых органных дисфункций;
3. выбор метода анестезии, по показаниям консультация анестезиолога-реаниматолога.

При нагноившейся кисте челюсти показано вскрытие и дренирование (цистотомия).

Показания к операциям при кисте челюсти

Операция	Объём операции	Показания
Цистэктомия	полное удаление оболочки кисты; дефект можно заместить остеопластическими материалами	оболочку можно удалить без опасности повредить соседние зубы, сосудисто-нервные пучки, стенки верхнечелюстной пазухи и полости носа
Цистостомия	создание соустья между полостью кисты и полостью рта	1. в полость кисты проецируются **3 интактных зуба и более**, на рентгенограмме у их корней не определяется периодонтальная щель; 2. большая киста верхней челюсти с разрушением костного дна полости носа и нёбной пластинки; 3. обширная киста нижней челюсти с истончением основания **менее 0,5 см**; 4. опасность повредить нижнечелюстной сосудисто-нервный пучок; 5. врастание кисты в верхнечелюстную пазуху или полость носа.
Марсупиализация	двухэтапная операция: сначала цистостомия, затем удаление остатков оболочки и свищевого хода	метод выбора для снижения травматичности и риска осложнений
Цисториносинусостомия	удаление оболочки кисты с радикальной операцией на верхнечелюстной пазухе и сообщением с нижним носовым ходом; при эндоскопической операции расширяют естественное соустье	киста челюсти проникает в верхнечелюстную пазуху: 1. интрасинусальная киста оттесняет дно пазухи вверх **на 1/3 высоты и более** (средняя и большая); 2. малая интрасинусальная киста с резким истончением костной перемычки: высок риск перфорации дна пазухи.

Методика костной пластики по величине дефекта

1. **1/4**: НКР с коллагеновой мембраной, одномоментная имплантация;
2. **2/4**: НКР с коллагеновой мембраной, нерезорбируемой мембраной;
3. **3/4**: НКР с нерезорбируемой мембраной, титановой сеткой;
4. **4/4**: НКР с нерезорбируемой мембраной, титановой сеткой, костные блоки (инлэй, онлэй), дистанционный остеогенез, «Graftless solutions».

НКР: направленная костная регенерация. Классификация остеопластических материалов приведена в разделе 3.2 PDF КР.

После декомпрессии кость восстанавливается аппозиционным ростом; полость промывают через трубку. Второй этап выполняется в среднем **через 0,5–1,5 года**.

Зуб удаляют, если его невозможно вылечить эндодонтически или ретроградно запломбировать.

При органосохраняющих операциях подлежат удалению «причинные» зубы

1. все временные зубы;
2. постоянные зубы, ставшие причиной кисты, если нельзя резецировать верхушки корней;
3. постоянные зубы, корни которых выступают в полость кисты **более чем на 1/2**.

Зуб также удаляют, если

1. подвижность зуба и атрофия альвеолярного отростка в области корней превышают II–III степень;
2. коронка разрушена настолько, что её невозможно восстановить;
3. корни значительно искривлены.

4.3 Кисты мягких тканей

При нагноившейся кисте мягких тканей лица и шеи показана цистотомия или пункция с эвакуацией гноя.

При срединной кисте шеи показана экстирпация кисты и свища **с резекцией тела подъязычной кости**. Лечение только хирургическое.

Под эндотрахеальным наркозом, горизонтальный разрез по кожной складке на уровне подъязычной кости; кисту выделяют тупо, не повреждая оболочку. Тело подъязычной кости резецируют клиновидно, **на 0,5 см** в обе стороны от свищевого хода.

При боковой кисте шеи показана цистэктомия. Лечение только хирургическое.

Под эндотрахеальным наркозом; разрез по переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы (безопаснее) или по верхней шейной складке (косметичнее). Резиновый выпускник удаляют **на 2–3-и сутки**.

При кисте подъязычной слюнной железы показана цистэктомия.

Для снижения риска рецидива выполняется марсупиализация или цистэктомия с удалением подъязычной или поднижнечелюстной слюнной железы.

Марсупиализацию выполняют при большой рануле или повреждении оболочки: иссекают купол кисты, стенку подшивают к слизистой оболочке, в полость вводят турунду.

4.4 Малоинвазивные операции

Пациентам **старше 16 лет** с боковой кистой шеи без свищевого хода или дермоидной кистой боковой области шеи при наличии оборудования возможно видеоэндоскопическое или роботассистированное удаление.

Под эндотрахеальным наркозом; заушный доступ (RAHI, face-lift) или тоннельный доступ из разреза в волосистой части затылочной области. Вакуумный дренаж удаляют **на 1–2-е сутки**.

Пациентам **старше 16 лет** с кистой поднижнечелюстной слюнной железы выполняется видеоэндоскопическая или роботассистированная цистэктомия либо цистэктомия с удалением железы.

4.5 Профилактика раневой инфекции

Перед операцией проводится профилактика инфекционных осложнений в области хирургического вмешательства, по показаниям обезболивание и противоотёчная терапия. Антибиотикопрофилактику проводят по национальным рекомендациям «СКАТ», «НАСКИ».

Антибактериальный препарат системного действия вводят в разовой терапевтической дозе.

Повторная интраоперационная доза вводится, если операция длится дольше **двух периодов полувыведения** препарата, или при массивной кровопотере.

Препарат вводят однократно; при продлении профилактики его отменяют **не позднее 24 часов** после операции, даже если стоит дренаж.

При длительном сообщении раны с полостью рта профилактику можно продлить **до 48, максимум 72 часов**.

Рекомендуется разработка локальных протоколов антибиотикопрофилактики.

Антибиотикопрофилактика

Операция	Препараты выбора	Альтернатива	Категория
Нет риска сообщения раны с полостью рта («чистая рана»)	не рекомендуется	не рекомендуется	B
Риск сообщения раны с полостью рта или околоносовыми пазухами	цефазолин + метронидазол или амоксициллин + клавулановая кислота	клиндамицин	A

1. цефазолин + метронидазол: внутривенно детям **с 1 месяца**, дозы по инструкции; взрослым **2 г** цефазолина + **500 мг** метронидазола **за 60 минут** до операции;
2. клиндамицин: взрослым **600–900 мг** внутривенно перед операцией;
3. амоксициллин + клавулановая кислота: внутривенно взрослым и подросткам **старше 12 лет**, дозы по инструкции.

Цефазолин, метронидазол и клиндамицин в КР отмечены знаком #: применение вне инструкции.

При инфицированной ране (застарелая травма, предшествующая инфекция, гной, нежизнеспособные ткани) антибактериальную терапию начинают до операции.

После операции применяют терапевтические дозы с учётом веса, возраста, функции почек и печени, тяжести инфекции, риска резистентности и локальных микробиологических данных; при инфицированной ране необходимо микробиологическое исследование. Препаратами выбора являются комбинации пенициллинов с ингибиторами бета-лактамаз, другие бета-лактамы, ко-тримоксазол, линкозамиды, аминогликозиды, фторхинолоны, гликопептиды, производные имидазола, прочие.

4.6 Лекарственная терапия

Для обезболивания применяют анальгетики и НПВП с учётом противопоказаний и возрастных ограничений.

При нарушении целостности стенок верхнечелюстной пазухи или после операции в области носа применяют деконгестанты и другие назальные препараты для уменьшения отёка слизистой оболочки пазухи и соустья, улучшения дренажа и предупреждения воспаления.

По показаниям проводится противоотёчная терапия глюкокортикоидами.

Местно применяют антисептики и дезинфицирующие средства для профилактики инфекционных осложнений.

4.7 Диета

При кисте нижней челюсти показана челюстная диета для снижения риска патологического перелома и нагноения.

При кисте подъязычной, поднижнечелюстной или околоушной слюнной железы из рациона исключают слюногонную пищу.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Небольшую кисту (**менее 3 зубов**) лечат амбулаторно.

Показания к госпитализации

1. небольшая киста при тяжёлой сопутствующей патологии;
2. киста **более 3 зубов**;
3. нагноение: экстренная госпитализация, в остальных случаях плановая.

Критерии выписки

1. острое воспаление купировано;
2. нет риска послеоперационного кровотечения.

5.2 Реабилитация

После операции проводится многоэтапная реабилитация до полного социального и физического восстановления.

Антибактериальная терапия в послеоперационном периоде назначается по показаниям. Осмотры и перевязки выполняются ежедневно, швы снимают **на 7–10-й день**, после чего пациента выписывают под амбулаторное наблюдение. Пребывание в стационаре до операции составляет **0–2** койко-дня, после операции **4–10**. После цистотомии и цистэктомии йодоформный тампон меняют **через 5–6 дней**, до 3–4 раз; к концу 3-й недели рана эпителизируется, полость пациент промывает сам. Полость уменьшается за счёт роста кости **за 1,5–2 года**.

При инфицировании сгустка необходимо создать отток экссудата между швами и промыть полость антисептиками; ежедневные промывания в течение **3–4 дней** нередко купируют воспаление. Если гнойный процесс сохраняется, края раны разводят, в полость вводят йодоформный тампон до гранулирования (**2–3 недели**).

5.3 Профилактика и диспансерное наблюдение

При первых симптомах кисты челюсти или мягких тканей показана консультация стоматолога-хирурга. Профилактика воспалительных одонтогенных кист заключается в своевременном лечении осложнённого кариеса и перикоронита.

Пломбирование зубов в зоне радикулярной кисты оптимально выполнять накануне или непосредственно перед операцией; перед операцией проводится санация полости рта. При парадентальных, фолликулярных и первичных кистах клинико-рентгенологический контроль после цистэктомии проводится **через 6 месяцев** и до восстановления кости; при фолликулярных и парадентальных кистах необходимо также наблюдение ортодонта. Наблюдение продолжают до полной нормализации клинико-рентгенологической картины.

При первых симптомах кисты мягких тканей показано УЗИ мягких тканей шеи.

При кисте верхней челюсти, растущей в полость носа или верхнечелюстную пазуху, показана консультация оториноларинголога.

При кисте мягких тканей шеи со свищевым ходом в области глотки или корня языка показана консультация оториноларинголога.

На исход влияют отрицательно

1. инфекционные осложнения;
2. нарушение ограничительного режима в раннем послеоперационном периоде;
3. нарушение диеты.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Кисты челюстно-лицевой области и шеи»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 28.07.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее июля 2028 года
Код в рубрикаторе	931_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии; Стоматологическая Ассоциация России
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Для кисты челюсти в разделе 3.2 сразу три операции названы оптимальными: цистэктомия — «как наиболее оптимального», цистостомия — «как наиболее оптимального», марсупиализация — «как метод выбора». Выбор операции определяется показаниями из комментариев.
- Антибиотикопрофилактику рекомендовано отменять не позднее 24 часов после операции, а комментарий допускает продление до 48–72 часов.
- В таблице антибиотикопрофилактики категории рекомендаций A и B, а сами рекомендации раздела 3.5 — C, 5.
- Текст PDF — скан с ошибками распознавания; цитаты журнала сверки приведены по распознанному тексту, таблицы сверены по изображениям страниц 28 и 35.